

2

治療中のポイント

モニタリングと早期発見・疑義照会

1 今どの段階か



治療前

ベースライン評価



治療中

定期モニタリング



治療後

長期フォロー

2 薬剤クラス別ここに注意

細胞障害性
抗がん薬

ドキソルビシン等。累積投与量に注意(換算表は第2回資料)

抗HER2
療法

トラスツズマブ等。可逆的な心機能低下、休薬で回復が期待できる

血管新生
阻害薬・
TKI

ベバシズマブ・スニチニブ等。高血圧・血栓症・QT延長に注意

ICI

ニボルマブ等。稀だが重篤な心筋炎。倦怠感・動悸を軽視しない

3 患者さんに伝える症状サイン



「いつもより1
段上で息が切れ
る」ようになっ
たら



「靴や靴下がき
つく感じる」よ
うになったら



「数日で1～
2kg以上増え
た」と感じたら



動悸・強い倦怠
感(ICI投与中は
特に軽視しな
い)

4 疑義照会のタイミング例

- ☐ 累積投与量が上限(目安400mg/m²)に近づいている
- ☐ 高リスク患者に心保護薬が使われていない
- ☐ QT延長を起こす薬剤同士の併用(制吐薬・アゾール系抗真菌薬・マクロライド系抗菌薬等)

緊急時の目安:ICI投与中の胸部症状・強い倦怠感・動悸 → その日のうちにトロポニン確認と循環器への連絡

